

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

1. Хмельницька міська (місцезнаходження МСЕК) пров. Жосипівський
2. медико-соціальна (профіль МСЕК)
експертна комісія

ДОВІДКА
до акта огляду медико-соціальною експертною комісією
(видається інваліду)

3. Серія 12 ААГ № 118254
4. Андросюк Олег Олександрович (прізвище, ім'я, по батькові інваліда)
5. Дата народження 23 02 1976 (число, місяць, рік) 6. Дата огляду 10 11 2022 (число, місяць, рік)
7. Огляд інваліда повторний (первинний, повторний)
8. Група інвалідності третя (словом) 3 01.02.2022
9. Причина інвалідності зп. зхв.
10. Інвалідність встановлена на строк до 01.12. 2024 року
11. Дата чергового переогляду 11 2024 (число, місяць, рік)

12. Висновок про умови та характер праці

Протипоказання важкої фізичної праці

13. Рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності

14. Підстава: акт огляду МСЕК № 1545

15. Дата 10.11.2022
(число, місяць, рік)



М.П.

Голова МСЕК

(Handwritten signature)
(підпис)
(І. П. Б.)

Міністерство охорони здоров'я України
Хмельницька міська Рада
29000 м. Хмельницький, пров. Проскурівський, 1
Хмельницька міська лікарня

ЗАТВЕРДЖЕНО

Код за ЄДРПОУ

0 2 7 7 4 3 8 4

Наказ МОЗ України

1 4 0 2 20 1 2 № 1 1 0

ВИПISKA

із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 12744.

У ХМП №2.

(найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)

1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого Андросюк Олег Омелянович.

2. Дата народження 2 3 0 2 7 6

(число, місяць, рік)

3. Місце проживання хворого: місто Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26/3, кв. 23.

4. Місце роботи (посада) Не працює.

5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі:
захворювання

направлення в стаціонар ХМП №2.

б) у стаціонарі: надходження ХВ№2

виписки або смерті (підкреслити) ХВ№2

(число, місяць, рік)

2 1 1 1 1 8

(число, місяць, рік)

2 1 1 1 1 8

(число, місяць, рік)

0 3 1 2 1 8

(число, місяць, рік)

6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення):

I. I 70.2 Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок III ст.

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці

Поступив в х/в №2 ХМЛ зі скаргами на біль в ногах при ходьбі, відчуття похолодання пальців, неможливість спати вночі через біль в н/кінцівках. Вважає себе хворим протягом 6 міс. коли вперше почав турбувати біль в ногах. В зв'язку з посиленням болю в н/к звернувся в ХМП №2, направлений в ХМЛ. При огляді н/к: трофічних розладів на шкірі не відмічається. На дотик права ступня холодніша за ліву, шкірні покриви обох ступней ціанотичні. Пульсація артерій збережена в пахових ділянках та в підколінних ямках, на ТАС не визначається.

При обстеженні встановлено діагноз (див. вище).

Хворий отримував консервативну терапію: латрен, варфарін, но-х-ша, віт. В1,В6,В12. Побічна дія ліків відсутня.

Після проведеного лікування стан хворого покращився, біль в н/к при ході турбує менше. Вночі спить. Ціаноз стоп зійшов.

В задовільному стані хворий виписаний для подальшого лікування амбулаторно.

ОБСТЕЖЕННЯ:

АН.КРОВІ: ШОЕ - 10 мм/г, НВ 140 г/л, ЛК $9,6 \times 10^9$, глюкоза – 4,5 м моль/л.

Протромбіновий індекс 95%.

Біох. ан. крові: Заг. білок 68,2 гр/л, сечовина 4,3 ммоль/л, загальний (непрямий) білірубін 14,6 мкмоль/л. АСТ 0,37 ммоль/л. АЛТ 0,55 ммоль/л, Калій 4,0 ммоль/л, Натрій 131 ммоль/л.

АН.СЕЧІ: без патології (з направлення).

ЕКГ: Ритм синусовий. ЧСС 56 уд/хв., ЕВС не відхилена. Ознаки ранньої реполяризації шлуночків.

ФГ ОГК від 24.06.18р.: Легені, серце – норма. (З направлення).

УЗД артерій н/к. 22.11.18р.: ЗСА, ПСА, глибокі а. - стінки потовщені, просвіти звужені з множинними а/с бляшками, з % стенозу до 30-35%. Тип кровотоку магістральний. ПКА – стінки потовщені. Тип кровотоку магістральний. ПВГА, ЗВГА – тип кровотоку магістральний, змінений.

8. Лікувальні і трудові рекомендації:

- Нагляд хірурга поліклініки.



Мариновський О.О.

Зав. відділенням

Яремюк В.С.

Міністерство охорони здоров'я України	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА	Форма первинної облікової документації
29000, м.Хмельницький, пров.Проскурівський,1, Хмельницька міська лікарня	№ 027/о
Код за ЄДРПОУ 02774384	ЗАТВЕРДЖЕНО
	Наказ МОЗ України
	14022012 № 110
ВИПСКА	
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 10468	
У (найменування і місцезнаходження закладу охорони здоров'я, куди направляється виписка)	
1. Прізвище, ім'я, по батькові хворого Андросюк Олег Омел'янович	
2. Дата народження 230276 (число, місяць, рік)	
3. Місце проживання хворого: область, район, місто(село) Хмельницький, вулиця Старокосянтинівське шосе, будинок 26/3, кв. 23	
4. Місце роботи (посада) Не працює	
5. Дати: а) в амбулаторно-поліклінічному закладі: захворювання направлення в стаціонар ХМП №2 б) у стаціонарі: надходження Неврологічне відділення №1 виписки або смерті (підкреслити) Неврологічне відділення №1	
(число, місяць, рік) (число, місяць, рік) 260918 (число, місяць, рік) 031018 (число, місяць, рік)	
6. Повний діагноз (основне захворювання, супутні захворювання та ускладнення): M54.4. ГОСТРА РАДИКУЛОПАТІЯ L5 ПРАВОРУЧ, ВИРАЖЕНА ЛЮМБОШІАЛГІЯ ПРАВОРУЧ З ПОРУШЕННЯМ СТАТИКИ ТА ФУНКЦІЇ ХОДИ. ОСТЕОХОНДРОЗ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА ІІІ СТУПЕНЯ	

7. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці

При поступленні скарги на болі в попереку, які віддають в праву ногу

АТ при поступленні 130/85 мм рт ст.

НЕВРОЛОГІЧНИЙ СТАТУС: в свідомості, емоційно лабільна менінгіальні знаки відсутні. Зіниці Д=S, рухи очних яблук в повному об'ємі, ністагму немає, обличчя симетричне. Слабкість тильного згинання великого пальця правої стопи. Гіпестезія L5 праворуч, ахілові рефлексy S>Д, с-м ласега праворуч, болючість п/в точок поперекового відділу. Сух. І періостальні рефлексy Д=S, колінні та ахілові Д=S, пат. стопні знаки відсутні.

ОБСТЕЖЕННЯ:

Рг ОГК: 24.06.2018р *Норм. (важкіше 12).*

РГ ШВХ: випрямлення фізіологічного лордозу ШВХ, ретролістез С4 на 0.1 см, склероз суглубових пластин С1-С7, загострення задніх кутів С4-С7, остеопіти по передньому контуру С5-С6. Висновок: остеохондроз, спондилоз Іст

РГ ПВХ: лівобічний сколіоз ПВХ Іст, ротація тіл L1-L4 на 50 гр, унковертебральний артроз L1-L5. Крайові остеопіти L2-L5, деформація тіла L2-L5, деформація тіла L2-L3, кили Шморля L2-L3, склероз суглубових пластин L1-L5, знижена висота між хребцевого диску L5-S1 в задніх відділах. Ретролістез L5 на 0,3 см.

Іліосакральні суглубові щілини звужені в в/в. Іліосакроліт, спонділоостеохондроз ПВХ II-III

ЕКГ: ритм синусовий, ЧСС 76 в хв., ЕВС горизонтальна, графіка без пат. змін

АНАЛІЗИ:

АН.КРОВІ: ШОЕ- 10 мм/г, НВ – 140,5 г/л, ЛК $9,6 \times 10^9$,

КСР негативна, Глюкоза крові 4,5 ммоль/л,

АН.СЕЧІ: 1010, рН 6.0, білка немає, ЛК 3-4 в п/з

8. Лікувальні і трудові рекомендації:

ЛІКУВАННЯ: еуфілін, ренальган, дексазон

Побічної дії на прийом лікарських препаратів під час лікування не спостерігалось

Випускається із стаціонару з покращенням під нагляд невролога по місцю проживання

РЕКОМЕНДОВАНО:- уникати переохолоджень та перевантажень на поперековий відділ,

- Неогабін 75 мг 2р в день 2 тижні,
- Санаторно-курортне лікування в м. Хмільник

Лікар

ЗАВ.ВІДД.

МИХАЛЮК І.С.



 Міністерство охорони здоров'я України КНП "ХОЛ" ХОР Україна Хмельницька область, м. Хмельницький, Пілотська вул., буд. 1 Судинної хірургії Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, Пілотська вул. буд. 1		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 02004717
КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради 39000, м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 027/о Затверджена наказом МОЗ України 14.02.2012 р. № 110
ВИПISKA із медичної карти стаціонарного хворого № IX-240819/19620		
Хворий Андросюк Олег Омелянович 23.02.1976 року народження		
Знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні: Судинної хірургії з 19.08.2024 по 26.08.2024		
Місце проживання: Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н. Мовчани		
Місце роботи/навчання:		
Скарги: Скарги на болі в нижніх кінцівках особливо при хотьбі, переміжну кульгавість, варикозне розширення вен н/к.		
Анамнез захворювання: погіршення стану відмічає протягом останнього часу		
Перебіг захворювання: Поступив у відділення судинної хірургії ХОЛ із скаргами на болі в нижніх кінцівках особливо при хотьбі, переміжну кульгавість, варикозне розширення вен н/к. Дообстежений, отримав відповідне лікування. Виписаний із стаціонару. Подальші рекомендації надано.		
Об'єктивно: Загальний стан хворого середньої важкості. Свідомість ясна, положення в ліжку активне. Шкірні покриви та слизові оболонки чисті, блідо-рожеві. Підшкірно жирова клітковина розвинена добре. Тони серця ослаблені. Дихання везикулярне. Лімфатична система без особливостей. Нервово-психічна система не змінена, контакту доступний, адекватний, орієнтований. Язик вологий, чистий. Живіт правильної форми, симетричний, приймає участь в акті дихання. Пальпаторно м'який, безболісний. Симптоми подразнення очеревини негативні. Перкуторно: звичайний звук. Перистальтика активна. Печінка не збільшена, не болоча. Селезінка не пальпується. При огляді шкіри на обох н/к - блілого кольору з ділянками гіперпигментації. Набряки на обох н/к. Варикозне розширення вен двобічно. Периферійна пульсація: a.femoralis dextra-задовільна, sinistra-задовільна. a.poplitea dextra-послаблена, sinistra-послаблена. a.dorsalis pedis dextra-послаблена, sinistra-послаблена. a.tibialis posterior dextra-послаблена, sinistra-послаблена. С-м Хоманса негативний, С-м Мозеса негативний. Рухи та чутливість обмежені на обох нижніх кінцівках.		
Клінічний діагноз: Основний - I70.2 Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок III ст. ХАН II-III ст. Супутній - I87.2 Хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок II ст.		
Дані обстеження		
Лабораторні аналізи:		
1. Сумарні антитіла до Treponema pallidum (діагностика сифілісу) (20.08.2024) - IgM+IgG - не виявлено ; 2. Глюкоза крові (20.08.2024) - Глюкоза крові - 5,3 ммоль/л; 3. Загальний аналіз сечі (20.08.2024) - Білок - не виявлено г/л; рН - 6 ; Епітелій перехідний - поодинокий в препараті в полі зору; Лейкоцити - 2-3 в полі зору; 4. Загальний аналіз крові (БЕЗ формули) (21.08.2024) - Лейкоцити - 9,0 10 ⁹ /л; Еритроцити - 4,10 10 ¹² /л; Гемоглобін - 135 г/л; Гематокрит - 43,6 %; Тромбоцити (PLT) - 288 10 ⁹ /л; ШОЕ - 10 мм/год;		
УЗД:		
судин нижніх кінцівок	22.08.2024	В артеріях стінки потовщені, вздовж стінок аск бляшки. Пульсація знижена до периферії. Стеноз в задніх в/гомілкових до 60%. В венах швидкості знижені, на компресію спадаються не повністю, кровотік з ретроградною хвилею.

Ендоскопічні дослідження :

Лікування:

1. гепарин 1,0 п/ш 2 р/д 7 днів.
2. плестазол 100 мг 1 таб 2 р/д 7 днів.
3. нормовен 1000 мг 1 таб 2 р/д 7 днів.
4. актовсгін 5,0 в/м 7 днів.
5. соларгін 100,0 в/в 7 днів.

Ефективність лікування: виписаний без змін

Стан на даний момент: задовільний

Рекомендації:

Плестазол 100 мг 1 таб 2 р/д 3 місяці. Нормовен 1000 мг 1 таб 1 р/д 2 місяці. Крестор 10 мг 1 таб 1 р/д тривало.

Завідуючий відділенням
Лікуючий лікар



МІЩЕНКО Євгеній Миколайович
МІЩЕНКО Євгеній Миколайович

УЗД судин нижніх кінцівок

(ліва/права)

П.І.Б.

Андросюк ОО

Дата

20.05.2019

Візуалізація на всьому протязі, частково, (не) прохідна

Наявність стенозу в ПКА стеноз до 40%

Наявність А/С бляшок у зв'язі з атеросклерозом артерій ехогенні включення при стенозі

Артерія	Діаметр	РІ	Тип кровоплину	Додатково
Черевна аорта	мм			
Заг. здухвинна а.				
Зов. здухвинна а.	11,0		гемодинамічний	
Гл. а. стегна	5,8		гемодинамічний	
Заг. стегнова а.	10,4		гемодинамічний	ТІМ 1,3 мм
Підколінна а.	6,5		гемодинамічний	зміщений
П. великогомілк. а.	3,2		гемодинамічний	зміщений
З. великогомілк. а.	3,6		гемодинамічний	зміщений
аа стони	(тисівка)		гемодинамічний	зміщений

Заключення: наявність А/С зміст в аа лівої кінцівки. Гемодинамічний стеноз в ПКА стеноз до 40%. Гемодинамічний стеноз в заг. стегновій артерії.

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
"Хмельницька обласна лікарня"
Хмельницької обласної ради
Найменування та місцезнаходження (поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
КНП «ХОЛ» ХОР

Код за ЄДРПОУ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
№ 028/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

1 4 0 2 / 1 2 № 1 1 0 1

Консультаційний висновок спеціаліста

1. Найменування закладу охорони здоров'я, який направив пацієнта на консультацію

2. Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта

Андросюк Олег
Олександрович

3. Дата народження

23.02.76
(число, місяць, рік)

4. Спеціальність, прізвище, ім'я, по батькові лікаря-консультанта

с.ф. хірург ХОЛ

5. Результати лабораторного дослідження

2

6. Результати функціонального, рентгенологічного та інших спеціальних досліджень:

УЗД органів

ОБ'єктивний сф.

Босі в стислій формі

7. Висновок спеціаліста (встановлений діагноз)

Обидві інтерпозичні серцеві судна
артерійного типу, ХНН 2-б-ст. Г.

8. Рекомендації:

1. Лікування 100 мг 17.



 Міністерство охорони здоров'я України КНП "ХОЛ" ХОР Україна Хмельницька область, м. Хмельницький, Пілотська вул., буд 1 Судинної хірургії Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, Пілотська вул. буд 1		Код форми за ЗКУД Код закладу за ЗКПО 02004717 МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 0 2 7 / о Затверджена наказом МОЗ України 14.02.2012 р. № 110
КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради 29000 м. Хмельницький, вул. Пілотська, 1 02004717		

ВИПИСКА із медичної карти стаціонарного хворого №IX-250520/11246

Хворий Андросюк Олег Омелянович 23.02.1976 року народження

**Знаходився на стаціонарному лікуванні у Судинної хірургії
з 20.05.2025 по 26.05.2025**

Місце проживання:

Україна, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, Мовчани

Місце роботи/навчання:

Скарги:

скарги на раптовий біль в правій нижній кінцівці особливо при ходьбі, переміжну кульгавість, варикозне розширення вен н/к.

Анамнез захворювання:

Хворіє протягом останніх років, відмічає погіршення за останній час.

Т. С: 36,6 **ЧСС,** уд. за 1 хв.: 72 **ЧДД,** р./хв.: 17

Перебіг захворювання:

Пацієнт поступив у відділення судинної хірургії із клінікою облітеруючого атеросклерозу артерій н/кінцівок та варикозного розширення вен н/кінцівок. Дообстежений. Призначено курс консервативної терапії. Після проведеного лікування стан пацієнта покращився. Пацієнт виписується зі стаціонару у задовільному стані. Рекомендації дано

Об'єктивно:

Загальний стан хворого середньої важкості.

Свідомість ясна, положення в ліжку активне.

Шкірні покриви та слизові оболонки чисті, блідо-рожеві.

Підшкірножирова клітковина розвинена добре.

Тони серця чисті. Дихання везикулярне.

Лімфатична система без особливостей.

Нервово-психічна система не змінена, контакту доступна, адекватна, орієнтована.

Язик вологий, чистий. Живіт правильної форми, симетричний, приймає участь в акті дихання. Пальпаторно м'який, безболісний. Симптоми подразнення очеревини негативні. Перкуторно: звичайний звук. Перестальтика активна. Печінка не збільшена, не болюча. Селезінка не пальпується.

При огляді шкіри на обох н/к - блідого кольору з ділянками гіперпигментації. Набряки наявні на обох н/кінцівках.

Варикозне розширення вен на обох нижніх кінцівках. Переферійна пульсація: а. femoralis dextra-задовільна, sinistra-задовільна. а. poplitea dextra-послаблена, sinistra-послаблена. а. dorsalis pedis dextra-послаблена, sinistra-послаблена. а. tibialis posterior dextra-послаблена, sinistra-послаблена. С-м Хоманса негативний, С-м Мозеса негативний. Рухи та чутливість обмежені незначно.

Клінічний діагноз:

Основний - I70.20 Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок Іст. ХАН Іст.

Супутній - I83.9 Варикозна хвороба нижніх кінцівок. ХВН Іст.

Дані обстеження

Лабораторні аналізи:

- Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) (21.05.2025) - Активований частковий тромбопластиновий час - 31.07 сек.;
- Білірубін загальний (TBIL) (21.05.2025) - Білірубін загальний (TBIL) - 13,47 мкмоль/л;
- Білірубін непрямої (NBIL) (21.05.2025) - Білірубін непрямої (NBIL) - 7,1 мкмоль/л;
- Білірубін прямої (DBIL) (21.05.2025) - Білірубін прямої (DBIL) - 6,42 мкмоль/л;

Загальний аналіз крові (СТАЦІОНАР)	
(21.05.2025) - Лейкоцити (WBC) - 5,32 $10^9/L$; Еритроцити (RBC) - 5,63 $10^{12}/L$; Гемоглобін (HGB) - 172 г/л; Гематокрит (HCT) - 0,538 l/l; Середній об'єм еритроцитів (MCV) - 95,6 fl; Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) - 30,6 пкг; Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) - 320 г/дл; Тромбоцити (PLT) - 141 $10^9/L$; Середній об'єм тромбоцитів (MPV) - 13,1 fl; Відносна кількість лімфоцитів (LYM%) - 34,6 %;	
5. Відносна кількість нейтрофілів (NEU%) - 56,6 %; Тромбоцит (PCT) - 0,185 %; Абсолютна кількість лімфоцитів (LYM #) - 1,84 $10^9/L$; Абсолютна кількість моноцитів (MON #) - 0,36 $10^9/L$; Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) - 1 мм/год; Ширина розподілу еритроцитів за об'ємом (RDW-CV) - 13,4 %; Абсолютна кількість еозинофілів (EOS #) - 0,1 $10^9/L$; Відносна кількість еозинофілів (EOS%) - 1,9 %; Відносна кількість базофілів (BAS%) - 0,2 %; Абсолютна кількість базофілів (BAS #) - 0,01 $10^9/L$; Абсолютна кількість нейтрофілів (NEU#) - 3,01 $10^9/L$; Ширина розподілу тромбоцитів за об'ємом (PDW) - 16,5 %;	
6. Міжнародне нормалізоване співвідношення (MNV) (21.05.2025) - Міжнародне нормалізоване співвідношення - 1,34 index;	
7. Протромбіновий час (21.05.2025) - Протромбіновий час - 15,02 сек.;	
8. Сумарні антитіла до Treponema pallidum (діагностика сифілісу) РМП (21.05.2025) - Антитіла IgM до Treponema pallidum - не виявлено ; Антитіла IgG до Treponema pallidum - не виявлено ;	
9. Тромбіновий час (21.05.2025) - Тромбіновий час - 16,30 сек.;	
10. Фібриноген (21.05.2025) - Фібриноген - 3,01 г/л;	
11. Холестерин (ХС) (21.05.2025) - Холестерин (ХС) - 4,4 ммоль/л;	
12. Аламініаміотрансфераза (АЛТ) (21.05.2025) - Аламініаміотрансфераза (АЛТ) - 41 Од/л;	
13. Аспаргатаміотрансфераза (АСТ) (21.05.2025) - Аспаргатаміотрансфераза (АСТ) - 36 Од/л;	
14. Визначення груп крові за системою АВ0 та Rh. (21.05.2025) - Група крові за системою АВ0 - А(II) ; Резус-фактор (Rh) - (+)позитивний ;	
15. Хлориди (Cl) (21.05.2025) - Хлор крові - 107 ммоль/л;	
16. Креатинін (21.05.2025) - Креатинін - 90,53 мкмоль/л;	
17. Глюкоза в крові натщесердце (21.05.2025) - Глюкоза крові - 5,2 ммоль/л;	
18. Натрій (Na) (21.05.2025) - Натрій - 147 ммоль/л;	
19. Калій (K) (21.05.2025) - Калій - 5 ммоль/л;	
20. Загальний білок (21.05.2025) - Загальний білок - 76,67 г/л;	
21. Сечовина крові (21.05.2025) - Сечовина крові - 4,9 ммоль/л;	
22. Загальний аналіз сечі (21.05.2025) - Глюкоза - - 0 ммоль/л; Білок - - 0 г/л; Жовчні пігменти (білірубін) - - 0 мкмоль/л; Жовчні пігменти (уробіліноген) - 3 - 133,0 мкмоль/л; рН - 6 ; Кетони - - 0 ммоль/л; Нітри - - ; Прозорість - Transparent ; Колір - Yellow ; Клітини плоского епітелію - 7 клітин/мкл; Клітини перехідного епітелію - 0-0 клітин/мкл; Клітини нирково епітелію - 0-0 клітин/мкл; Лейкоцити - - 0 клітин/мкл; Свіжі еритроцити - 0-0 клітин/мкл; Змінені еритроцити - 0-0 клітин/мкл; Гіалінові циліндри - 0-0 клітин/мкл; Зернисті циліндри - 0-0 клітин/мкл; Кристали трипельфосфату - 0-0 клітин/мкл; Лейкоцитарні циліндри - 0-0 клітин/мкл; Восковидні циліндри - 0-0 клітин/мкл; Аморфні урати - 0-0 клітин/мкл; Кристали оксалату кальцію - 0-0 клітин/мкл; Слиз - 7 клітин/мкл; Бактерії - 0-0 клітин/мкл; Солі кристалів сечової кислоти - 0-0 клітин/мкл; Дріжджі - 0-0 клітин/мкл; Аморфні фосфати - 0-0 в полі зору; Питома вага - 1.023 ; Еритроцити - - 0 клітин/мкл; Альбумін - + 0.15 г/л; Аскорбінова кислота - + 1.4 ммоль/л; Лейкоцити - 14 клітин/мкл; Скупчення лейкоцитів - 0-0 клітин/мкл;	

УЗД:

УЗД вен і артерій нікінцівок	21.05.2025	Артерії - діаметр в нормі , ас бляшки 3-5мм вздовж стінок , що стенозують просвіт в задніх в'гомілкових 40-50% в передніх в'гомілкових -40%. Вени - на момент огляду глибокі вени не тромбовані , неспроможність остіальних клапанів
---------------------------------	------------	--

Ендоскопічні дослідження :

Лікування:

1. диклофенак/ діклофенак натрію, розчин для ін'єкцій, 25мг/мл по 3мл в ампулі; по 5 ампул в однобічному блістері; по 1 блістеру у пачці - доза 3 мл, внутрішньом'язово одноразово 7 дн.
2. нардін розчин для ін'єкцій по 100 мг/мл по 0.6 мл (60 мг), у попередньо наповненому шприці. по 2 шприци у блістері, по 5 блістерів в картонній пачці. - доза 0.6 мл, підшкірно кожний день 7 дн.
3. нормовен табл, в/плів. обол. №30 (10x3) - доза 1 таблеток, орально кожний день 7 дн.

Ефективність лікування: виписаний з поліпшенням

Стан на даний момент: ближче до задовільного

Т. С: 36.7 ЧСС, уд. за 1 хв.: 80 ЧДД, р/хв.: 16

Рекомендації:

Ксарелто 2.5мг 2р\добу, аспірин-кардіо 100мг 1р\добу, еластичний трикотаж Пклас компресії. Контроль УЗД вен контроль 1р на рік. Спостереження хірурга за місцем проживання. Контроль у судинного хірурга через 1 місяць.

Явка до сімейного лікаря дата 27.05.2025

27.05.2025 року

В.о. завідуючого відділенням:

Лікуючий лікар

ДО Віталій Анатолійович

БЕШЕТОВ Юрій Леонідович

